

สถานการณ์จำลองเสมือนจริง การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางการพยาบาล
(The 2nd Skill contest simulation) 2569



สถานการณ์จำลองเสมือนจริง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response with Pulseless Ventricular Tachycardia)

กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้เรียน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

1.นายวิวัฒน์ห้วยทราย 2.นางสาวนาตาชา อมฤทธิ

3.นางสาวคณิตศร คำจูน 4.นางสาวณัฏฐารีย์ บุตรสา

ผู้พัฒนาบท อาจารย์แสงวรรณ ตั้งแสงสกุล และอาจารย์ทิพย์สุตา สายโสภา

เบอร์โทรศัพท์และ e-mail ของผู้พัฒนาบทหลัก : 084-0230689 Warissara.p@nrru.ac.th

เป้าหมายการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้

เป้าหมาย	วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถ
เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้รับความปลอดภัย	1. การประเมินอาการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในระยะวิกฤตอย่างครอบคลุม 2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในระยะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ระยะเวลา

Brief	Scenarios	debrief	Spare time
3 นาที	10 นาที	20 นาที	2 นาที

บทบาทของผู้เรียนในสถานการณ์จำลอง

ผู้แสดง	บทบาท
อาจารย์คนที่ 1 (Fa: Facilitator)	ผู้ควบคุมสถานการณ์ และผู้ให้ข้อมูลเป็นระยะๆ ตามที่ น.ศ. ร้องขอ
อาจารย์คนที่ 2 (Con: Confederate)	แพทย์
บทบาทผู้เรียน (Learners' Role)	พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรม
หุ่นที่ใช้ CPR	ผู้ป่วย

บทบาทของผู้ช่วยในสถานการณ์จำลอง (confederate) (เช่น แพทย์ เป็นต้น)

แพทย์ :

- รับรายงานจากพยาบาลทางโทรศัพท์และ order คำสั่งรักษาทางโทรศัพท์ เนื่องจากแพทย์อยู่ OPD และกำลังเดินทางเข้ามา ให้รายงาน case ตามหลัก ISBAR
- กระตุ้นนักศึกษาเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงที่แย่ง แล้วนักศึกษาไม่สามารถประเมินหรือปฏิบัติกิจกรรมที่ควรปฏิบัติใน stage นั้น ๆ ได้ถูกต้อง และคอยตั้งคำถามที่ช่วยชี้แนะหรือ guide ให้นักศึกษาได้คิดทบทวนการปฏิบัติการพยาบาลว่าปฏิบัติได้ถูกต้องครอบคลุมแล้วหรือไม่

รายละเอียดสถานการณ์และประวัติผู้ป่วย

ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วย ชายไทย อายุ 55 ปี

CC: เหนื่อย ใจสั่น 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

PI: 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ใจสั่น วิงเวียนเล็กน้อย เหนื่อยเมื่อเดิน แต่ยังพูดเป็นประโยคได้ มีอาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อย

ประเมินอาการแรกรับ : ผู้ป่วยรู้สึกตัว E4V5M6 เจ็บแน่นหน้าอก pain score 2/10 คะแนน รู้สึกวิงเวียนศีรษะเวลาลุกขึ้น แต่ไม่เคยหมดสติ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีอาการบวมที่ขาหรือหน้า

ประวัติโรคประจำตัว:

- โรคความดันโลหิตสูง 10 ปี F/U รับประทานต่อเนื่อง
- โรคไขมันในเลือดสูง 5 ปี F/U รับประทานต่อเนื่อง
- มีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิด Atrial Fibrillation เป็นมา 1 ปี แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง ขาดยามา 2 ด.

ยาที่ใช้ประจำ:

- Amlodipine 5 mg PO OD
- Atorvastatin 20 mg PO HS
- กล้วยไม้แพ้ยาลูกแพ้อาหาร ปฏิเสธการใช้สารเสพติด

ผลการตรวจร่างกาย

สัญญาณชีพแรกรับ: BP 118/72 mmHg, HR 145 bpm, RR 22 bpm, SpO₂ 95 % (RA)

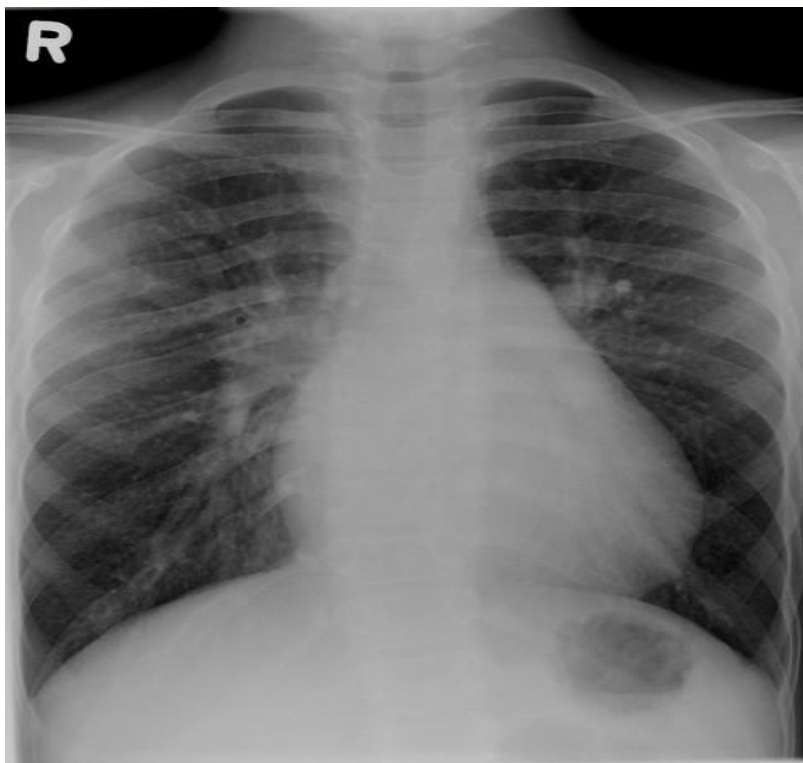
Pain score 2/10 ECG: Atrial Fibrillation with rapid ventricular response HR 146 bpm

Weight: 60 kg Height: 165 cm BMI: 22.04 kg/m²

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Laboratory Results:	Na: 140	K: 3.0	CL: 105	HCO ₃ : 24
	Urea: -	Cr: 1.5	Glu: 110	Ca: 8.8
	Mg: 1.5	PO ₄ : 3.5	Albumin:	
ABG or VBG	pH:	PCO ₂ :	PO ₂ :	HCO ₃ :
	Lactate:	FiO ₂ :		

Blood	WBC: 10,800 cells/mm ³	Hb: 13.2 g/dL	Hct: 39.8%	Plt: 245,000/mm ³
Other	Troponin T Negative , CK-MB: 5 ng/mL			
(ECG, CXR, CT, etc.)				



CXR : Pulmonary edema เล็กน้อย

เอกสารอ้างอิง (APA^{7th})

- American Heart Association. (2020). 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S337–S357. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>
- Joglar, J. A., Chung, M. K., Armbruster, A. L., et al. (2024). 2024 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation. *Circulation*, 149(1), e1–e156.
- สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2568). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ในประเทศไทย พ.ศ. 2568. กรุงเทพมหานคร: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย.

การเตรียม Simulator

อุปกรณ์ (Equipment)	วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies)	ยา (Medications)
1. หุ่นจำลองผู้ป่วยผู้ใหญ่ (High-fidelity Simulator)	1. แผ่นติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG electrodes)	1. Amiodarone injection 150 mg/3 mL
2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	2. แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillation pads)	2. Amiodarone injection 300 mg
3. เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) ที่สามารถทำ Synchronized Cardioversion ได้	3. ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV administration set)	3. Epinephrine injection 1 mg/10 mL (1:10,000)
4. รถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Crash Cart)	4. สายต่อหลอดเลือดดำ (IV extension set)	4. Metoprolol injection 5 mg/5 mL
5. เครื่องให้ออกซิเจน	5. เข็มเปิดหลอดเลือดดำ เบอร์ 18 และ 20	5. Diltiazem injection
6. หน้ากากให้ออกซิเจนชนิดมีถุงสำรอง (Non-rebreather mask)	6. สารน้ำ 0.9% Normal Saline (NSS)	6. Magnesium sulfate injection
7. สายให้ออกซิเจนชนิดแคนนูลา (Nasal cannula)	7. กระบอกฉีดยา ขนาด 3, 5, 10 และ 20 มิลลิลิตร	7. Potassium chloride (KCl) injection
8. ถุงลมช่วยหายใจพร้อมหน้ากาก (Bag-Valve-Mask; BVM)	8. สำลี แอลกอฮอล์ และผ้าก๊อช	8. Midazolam injection
9. เครื่องดูดเสมหะ (Suction machine)	9. ถุงมือสะอาด	9. 0.9% Normal Saline Flush
10. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	10. พลาสเตอร์และเทปติดสาย	10. 0.9% Normal Saline for intravenous infusion
11. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter)	11. ภาชนะทิ้งของมีคม	
12. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ (Infusion pump)	12. กระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	

การดำเนินสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

State	สภาวะผู้ป่วย	การปฏิบัติของผู้เรียน	หมายเหตุ
state 1 Assessment	ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชายไทย อายุ 55 ปี 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ใจสั่น วิงเวียนเล็กน้อย เหนื่อยเมื่อเดิน แต่ยังพูดเป็นประโยคได้ มีอาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อย ประเมินอาการแรกพบ : ผู้ป่วยรู้สึกตัว E4V5M6 เจ็บแน่นหน้าอก pain score 2/10 คะแนน รู้สึกวิงเวียนศีรษะเวลาลุกขึ้น แต่ไม่เคยหมดสติ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีอาการบวมที่ขาหรือหน้า สัญญาณชีพแรกพบ: BP 118/72 mmHg, HR 145 bpm, RR 22 bpm, SpO₂ 95 % (RA) ผลตรวจ K⁺ 3.0 mEq/L, Mg²⁺ 1.5 mg/dL, Troponin Negative Pain score 2/10 ECG: Atrial Fibrillation with rapid ventricular response HR 146 bpm	1. การประเมินสภาพผู้ป่วยแรกพบ - ประเมิน Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure - ประเมินสัญญาณชีพ อาการและอาการแสดง ได้แก่ อาการใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ระดับความรู้สึกตัว อาการเหนื่อย หายใจไม่เต็ม ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก ระดับความรู้สึกตัวลดลง ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 cc/kg/hr. และสัญญาณชีพ 2. รายงานแพทย์ ตามหลัก ISBAR - แนะนำชื่อพยาบาลที่รายงานแพทย์ ชื่อหอผู้ป่วย ชื่อผู้ป่วย - อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน โรคประจำตัว การผ่าตัด - การประเมินอาการและอาการแสดง รวมถึงปัญหาที่พบการพยาบาลและผลของการให้การพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ และการตรวจร่างกายเพิ่มเติม - ข้อเสนอแนะ และการรักษา เพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาล 3.ให้การพยาบาล/ให้ยาตามแผนการรักษา 3.1 ดูแลตรวจ ECG 12 leads ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3.2 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ Oxygen cannula 3 lpm 3.3 ดูแลส่งตรวจ lab E'lyte, Ca, Mg, PO₄, Trop-T, CK-MB ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3.4 ดูแลให้ยา Amiodarone 150 mg in D5W 100 ml IV drip in 30 min then Amiodarone 300 mg in D5W 100 ml IV drip in 12 hr. ตามแผนการรักษาของแพทย์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา 3.5 เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ Hemodynamic status อย่างต่อเนื่อง	กรณีที่นักศึกษาไม่ประเมินผู้ป่วย Fa : กระตุ้น โดยผู้ป่วยพูด "พยาบาลครับ ผมหายใจไม่อิ่ม ใจสั่นมากขึ้น ผมเหนื่อยมากเลย" เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการ ประเมินสภาพผู้ป่วย และรายงานแพทย์เรียบร้อยแล้ว หากผู้เรียนประเมินครบและรายงานแพทย์ได้ถูกต้อง ดำเนินต่อ State 2 หากประเมินล่าช้า ผู้ป่วยเริ่มเหนื่อยมากขึ้น BP ลดลง HR เพิ่มขึ้น

State	สถานะผู้ป่วย	การปฏิบัติของผู้เรียน	หมายเหตุ
state 2	ผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว E1V1M1 - EKG = Showed Pulseless Ventricular Tachycardia A&B : Apnea C: No pulse central cyanosis D: E1V1M1 -Adrenaline administration -EtCO₂=25 mmHg.	- ประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย - ขอความช่วยเหลือ/Activate Code Blue - ประเมินการหายใจและชีพจร ภายใน 10 วินาที - ติด Defibrillator และวิเคราะห์ จังหวะหัวใจ - Defibrillation 200 J Biphasic - เริ่ม High-quality CPR ทันที - กดหน้าอก 100–120 ครั้ง/นาที - ลึก 5–6 ซม. - เปลี่ยนผู้กดทุก 2 นาที - เปิด IV/IO - ให้ Epinephrine 1 mg IV ทุก 3–5 นาที (กรณีไม่มีชีพจร) - หลังช็อกครั้งที่ 3 ให้ Amiodarone 300 mg IV Push - วิเคราะห์จังหวะหัวใจและค้นหา Hs & Ts1. เตรียม defibrillator สำหรับการ Shock 200J - Chest compression เปลี่ยนคนทำ ทุก 2 นาที - ช่วยหายใจ 10 ครั้ง/นาที - Analyze EKG - Check pulse	กรณีที่นักศึกษาไม่ประเมินผู้ป่วย และให้คำแนะนำ Fa : กระตุ้น โดยแสดงบทบาทเป็นญาติ "คุณพ่อเป็นอะไร ทำไมคุณพ่อดูเหนื่อยมากเลย กลับบ้านไปจะมีอาการเหมือนเดิมอีกไหม " เมื่อนักศึกษาประเมินผู้ป่วยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปที่บ้านเรียบร้อยแล้ว หากผู้เรียนดำเนินการตาม ACLS ถูกต้อง ผู้ป่วยเข้าสู่ ROSC
state 3	ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการใจสั่นทุเลาลง ผิวน้ำและปลายมือปลายเท้าอุ่น ไม่ซีดเขียว Capillary refill <2 วินาที หายใจไม่หอบเหนื่อย สัญญาณชีพปกติ BT 37 °C, RR 24 bpm, PR 96 bpm, BP 100/60 mmHg. SpO₂ 98% ECG show Atrial Fibrillation HR 90 bpm	- ประเมิน ABCDE ซ้ำ - ประเมินระดับความรู้สึกตัว (GCS) ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย - ติดตาม Cardiac Monitor และ ECG 12 leads - ประเมินชีพจร ความดันโลหิต และ SpO₂ อย่างต่อเนื่อง - ส่งตรวจ Electrolytes, ABG และ Cardiac biomarkers ซ้ำตามแผนการรักษา - แก้ไข Hypokalemia และ Hypomagnesemia ตามแผนการรักษา	จบสถานการณ์

State	สถานะผู้ป่วย	การปฏิบัติของผู้เรียน	หมายเหตุ
		- 0.9% Normal Saline + Potassium Chloride 40 mEq IV infusion drip 80 cc/hr. - Magnesium sulfate 2 g IV infusion ใน 50–100 mL NSS ให้ภายใน 15–30 นาที 7. รายงานแพทย์ และเตรียมส่งต่อ CCU	

การสรุปผลการเรียนรู้ (Debrief) 20 นาที

ขั้นตอนที่ 1 Gathing (การรวบรวมข้อมูล)

G1: สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากเสร็จสิ้นฝึกปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง

G2: ให้ผู้เรียนเล่าว่า เกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์บ้าง

ขั้นตอนที่ 2 Analyze (การวิเคราะห์)

A1: ประเมินผู้ป่วยแล้วพบอะไรบ้าง

A2: สอบถามว่า ครูสังเกตเห็น “นักศึกษาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย” เพราะอะไรถึงทำเช่นนั้น

A3: อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ ตัดสินใจ Start CPR, หรือ รายงานแพทย์ หรือ Defibrillation

A4: ขอให้บทวนและวิเคราะห์วิธีการสื่อสารในทีม ตามหลัก closed loop communication

ขั้นตอนที่ 3 summarize (การสรุปการเรียนรู้)

1. อภิปรายข้อดีและโอกาสพัฒนาในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในครั้งต่อไป

**แบบประเมินการเรียนรู้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม**



**แบบประเมินการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม**

ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา.....บพบาท.....
 ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา.....บพบาท.....
 ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา.....บพบาท.....
 ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา.....บพบาท.....

สถานการณ์

ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response with Pulseless Ventricular Tachycardia

เป้าหมายการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้

เป้าหมาย	วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถ
เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้รับความปลอดภัย	1. การประเมินอาการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในระยะวิกฤตอย่างครอบคลุม 2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในระยะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถสื่อสารเชิงวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

คำชี้แจง จงใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องของการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน State 1 State 2 State 3 และเมื่อสิ้นสุด Scenario

- 4 หมายถึงปฏิบัติได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
 3 หมายถึงปฏิบัติได้ถูกต้องบางส่วน และ / ไม่ปฏิบัติ 1 อย่าง
 2 หมายถึงปฏิบัติได้ถูกต้องบางส่วน และ / ไม่ปฏิบัติ 2 อย่าง
 1 หมายถึงปฏิบัติได้ถูกต้องบางส่วน และ / ไม่ปฏิบัติ 3 อย่าง หรือ
 ปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

แบบประเมินผล (Evaluation Form)

สถานการณ์จำลองเรื่อง ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation
with Rapid Ventricular Response with Ventricular Fibrillation

รายการประเมิน	Complete (4 คะแนน)	Incomplete (1-3 คะแนน)	Not done (0 คะแนน)	คะแนนที่ได้
State 1 Assessment				
1. การประเมินสภาพผู้ป่วยแรกพบ - ประเมินสัญญาณชีพ อาการและอาการแสดง ได้แก่ อาการเหนื่อย หายใจไม่อึด ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก ระดับความรู้สึกตัวลดลง ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 cc/kg/hr. ความดันโลหิตต่ำลง	4	1-3	0	
2.ให้การพยาบาล/ให้ยาตามแผนการรักษา 2.1 ดูแลตรวจ ECG 12 leads ตามแผนการรักษาของแพทย์ 2.2 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ Oxygen cannula 3 lpm 2.3 ดูแลส่งตรวจ lab E'lyte, Ca, Mg, PO4, Trop-T, CK-MB ตามแผนการรักษาของแพทย์ 2.4 ดูแลให้สารน้ำ 0.9 % NSS 1000 cc IV drip 80 CC/hr. ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3. ดูแลให้ยา Amiodarone 150 mg in D5W 100 ml IV drip in 30 min then Amiodarone 300 mg in D5W 100 ml IV drip in 12 hr. ตามแผนการรักษาของแพทย์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา	4	1-3	0	
3. รายงานแพทย์ I – introduction/ Identify การระบุตัวตัวผู้รายงาน หน่วยงาน ชื่อผู้ป่วย หอผู้ป่วย S – Situation สถานการณ์ที่ทำให้ต้องรายงาน A – Assessment การประเมิน R – Recommendation ข้อเสนอแนะ	4	1-3	0	
State 2 VF , Cardiac arrest				
1. เรียกผู้ป่วยตั้ง ๆ ตบ่าแรงๆ	4	1-3	0	
2. เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนอง แจ้งทีม	4	1-3	0	
3. ประเมินการหายใจและชีพจรบริเวณ carotid pulse (5-10 วินาที)	4	1-3 -นาน >10 วินาที/ < 5 วินาที -จับชีพจรตำแหน่งอื่น	0	
4.รองกระดาน (cardiac board)	4	1-3	0	
5.Chest compression และ ช่วยหายใจ mask	4	3 (ไม่ปั๊ม bag)	0	
6.ใช้ Paddle ประเมิน EKG และประเมินผล	4	-	0	
7.รายงานผล EKG	4	3 (ถ้าอ่านเป็น VF)	0 (อ่านเป็นอื่น ๆ)	

รายการประเมิน	Complete (4 คะแนน)	Incomplete (1-3 คะแนน)	Not done (0 คะแนน)	คะแนนที่ได้
8.ช่วยแพทย์ defibrillator สำหรับการ Shock 200J (ครั้งที่ 1) 1) ทาเจล 2) เลือกโหมด 3) หมุนปรับพลังงาน 4) ไม่สัมผัสผู้ป่วยและเตียงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือน	4	3 (ไม่ทาเจล)	0 (เลือกโหมดผิด /หมุนปรับ พลังงานน้อย กว่า 200 J/ สัมผัสผู้ป่วยและ เตียงเมื่อได้ยิน สัญญาณเตือน)	
9.เปลี่ยนคน Chest compression เมื่อครบ 2 นาที	4	3 (ไม่เปลี่ยนคน)	0	
10. ประเมิน EKG และ Analyze: Asystole	4	1-3	0	
11. คลำ carotid pulse (5-10 วินาที)	4	3 -นาน >10 วินาที/ < 5 วินาที -จับชีพจร ตำแหน่งอื่น	0	
State 3 AF ,Return of spontaneous circulation (ROSC)				
1. Check BP, P, O ₂ Sat	4	1-3	0	
2.ประเมินระดับความรู้สึกตัว	4	1-3	0	
3. monitor EKG and Analyze EKG และ Check pulse	4	1-3	0	
คะแนนเต็ม	68			
คะแนนผ่าน	40.8			

ความสามารถในภาพรวม (Overall performance): ☐ Fail ☐ Borderline ☐ Pass ☐ Excellent

การแปลผลคุณภาพ

- เกณฑ์ผ่าน คือ คะแนน > 40.8 คะแนน หรือตั้งแต่ระดับดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักศึกษา

.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

วันเดือนปี.....